

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



杨少鹏(男)

项目号 T012280283

单位 西门子(中国)有限公司

联系电话 182****3079

项目简称 西门子中国

员工号

类别 员工

卡号 0010900178825718

部门 siemens

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 2222212130155



无锡新吴茂业分院(无锡爱康国宾门诊部有限公司)

检查日期 2022.12.13

33/6227

爱康国宾®

360°健康管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团,通过旗下多个品牌,为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理及医疗服务。截止2022年8月,爱康集团(包括并购基金)已在59大城市设有155家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	06
	检查详细结果	
4	历年主要异常指标对比	13
	历年数据对比及健康预测	
5	医学名词科普知识	15
	医学名词科普知识内容	

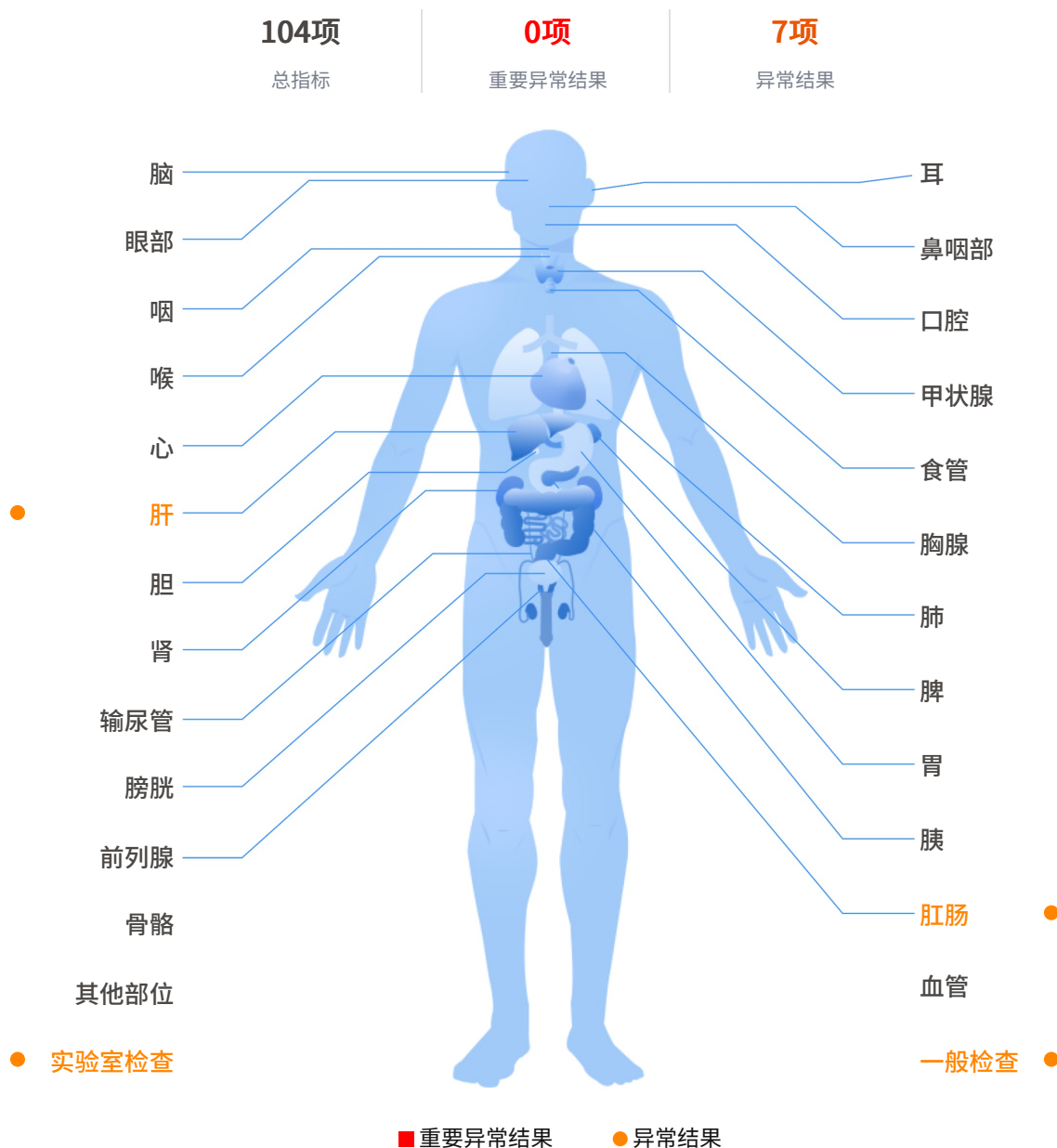
尊敬的**杨少鹏**先生，您好！

无锡新吴茂业分院（无锡爱康国宾门诊部有限公司）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2022年12月13日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 本次体检血压增高；未提供高血压病史
- 【2】 本次体检空腹血糖升高（6.64）；未提供糖尿病史
- 【3】 体重指数增高；中度脂肪肝；甘油三酯增高
- 【4】 尿酸增高
- 【5】 肛周湿疹



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 本次体检血压增高；未提供高血压病史

- 1、收缩压 ≥ 140 mmHg和/或舒张压 ≥ 90 mmHg为血压增高标准。
- 2、请近期监测血压，若三次以上非同日测得收缩压 ≥ 140 mmHg和/或舒张压 ≥ 90 mmHg，有高血压病之可能，建议去医院专科就诊，明确有否高血压病。
- 3、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式，戒烟限酒，低脂、低盐、合理膳食，坚持有氧运动，控制体重，减轻精神压力、保持心理平衡等。

02 本次体检空腹血糖升高（6.64）；未提供糖尿病史

- 1、空腹血糖增高主要见于糖尿病，偶可见于高糖饮食后；也可见于甲亢、严重肝病和胰腺疾病等。
- 2、建议复查空腹血糖，并检测餐后2小时血糖或糖耐量试验，请及时内分泌专科诊治。

03 体重指数增高；中度脂肪肝；甘油三酯增高

体重指数（体重(kg) $\div$ 身高(m)的平方） ≥ 24 为超重， ≥ 28 为肥胖。您的体重已属超重范围，同时合并中度脂肪肝、血脂偏高。超重和血脂高是高血压、冠心病的危险因素，也是糖尿病、高脂血症和高血液粘稠度等的病因；脂肪肝多由营养过剩、饮酒、药物损伤导致，加重可导致肝纤维化。您需要调整饮食结构，低脂、低热、少糖膳食，坚持有氧运动，减轻体重，限酒，慎用伤肝药物，定期复查，听取专科医生意见。

04 尿酸增高

- 1、多因饮酒、高蛋白或过食高嘌呤食物等引起血尿酸增高，提示嘌呤代谢紊乱和（或）尿酸排泄障碍，可为无症状的高尿酸血症。
- 2、高尿酸常与肥胖、高血压病、高脂血症、冠心病、2型糖尿病等代谢性疾病并存。高尿酸血症也是动脉硬化的危险因素，因此应引起您的注意。
- 3、及时调整饮食结构，忌食高嘌呤食物，如动物内脏、鱼卵、蟹黄、海鱼、豆类、香菇等，多吃五谷杂粮、奶制品、蛋类及水果蔬菜等低嘌呤食物，减少饮酒量。
- 4、建议动态观察，定期复查血尿酸（复查前三天不吃高嘌呤食物）。若持续增高，请到医院内分泌专科诊治。

05 肛周湿疹

- 1、避免各种外界刺激如烫、搔抓、过多使用肥皂、不适当的外用药等。
- 2、避免过劳及精神紧张，忌辛辣食物。
- 3、保持局部皮肤清洁，避免继发感染，重者到医院皮肤科就诊。



下载爱康APP
查看彩色报告

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：朱媛媛

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	175.0	cm		
体重	74.2	Kg		
体重指数	24.2		↑	18.5—23.99
收缩压	157	mmHg	↑	90.0—139.0
舒张压	91	mmHg	↑	60.0—89.0

初步意见

1.血压增高
2.体重指数增高

内科

检查者：李维家

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	64	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见

未见明显异常

外科

检查者：赵进南

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



下载爱康APP
查看彩色报告

皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	肛周皮肤浸渍，色素减退	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	

初步意见

肛周湿疹

眼科

检查者：张倩

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.2	
矫正视力(左)	1.5	
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
眼底镜检查	未见明显异常	
右眼非接触性眼压	15	mmHg
左眼非接触性眼压	15	mmHg

初步意见

未见明显异常

血常规

操作者：吴慧林 审核者：张景凤

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	5.4		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	5.43		4.3—5.8	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	171.00		130—175	g/L
红细胞比容	HCT	0.500		0.4—0.5	L/L
平均红细胞体积	MCV	92.40		82—100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.50		27.0—34.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	341.00		316—354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	11.70		10—16.5	%
血小板计数	PLT	260.00		125—350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	6.40		5—12.4	fL
血小板分布宽度	PDW	16.30		9—18.0	FL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	33.00		20—50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	60.70		40—75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.79		1.1—3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.30		1.8—6.3	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	43.24		37.8—51.0	fL
血小板压积	PCT	0.170		0.1—1.00	%
单核细胞百分比	MONO%	5.00		3—10	%
单核细胞绝对值	MONO	0.27		0.1—0.6	10~9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	1.0		0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.050		0.02—0.52	10~9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.35		0.0—1.0	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.02		0.0—0.06	10~9/L

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者： 吴慧林 审核者： 张景凤

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.025		1.010—1.025	
尿酸碱度	PH	6.0		4.5—8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL

小结	未见明显异常
----	--------

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者： 吴慧林 审核者： 张景凤

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	32.0		7—50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	20.4		7—40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	24.8		7—60	U/L
碱性磷酸酶	ALP	71.7		35—135	U/L
总胆红素	TBIL	20.8		0—21	umol/L
直接胆红素	DBIL	4.50		0—5	umol/L
间接胆红素	IBIL	16.30		0—17	umol/L
★ 总蛋白	TP	75.6		60—80	g/L
★ 白蛋白	ALB	54.4		35—55	g/L
★ 球蛋白	GLb	21.20		20—30	g/L

★ 白蛋白/球蛋白比值	A/G	2.6		1.2—2.8	
尿素	UREA	7.30		1.7—8.3	mmol/L
肌酐	Cr	105.60		44—106	umol/L
尿酸	UA	495.60	↑	210—420	umol/L
空腹血糖	FBG	6.64	↑	3.90—6.10	mmol/L
总胆固醇	TC	5.15		0—5.2	mmol/L
甘油三酯	TG	2.91	↑	0—2.26	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.04		0.91—1.68	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.92		0—4.14	mmol/L
磷酸肌酸激酶	CK	123.3		38—174	U/L
磷酸肌酸激酶同工酶	CK-MB	13.5		0—24	U/L
乳酸脱氢酶	LDH	152.4		109—245	U/L
幽门螺杆菌抗体	Hp-Ab	1.8		0.1—15	AU/mL
甲胎蛋白定量	AFP	2.39		0—20	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	0.25		0—5	ng/ml

小结

- 1.空腹血糖升高
- 2.尿酸增高
- 3.甘油三酯增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者： 李少峰

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律 正常心电图	

初步意见

未见明显异常

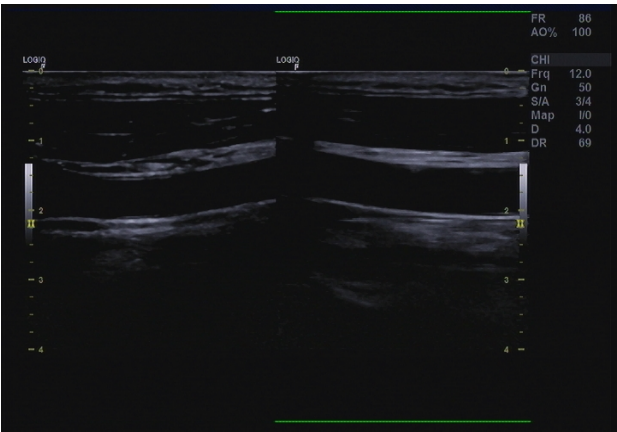
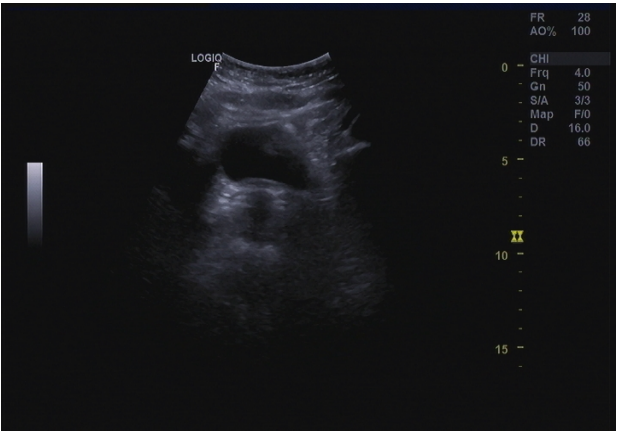
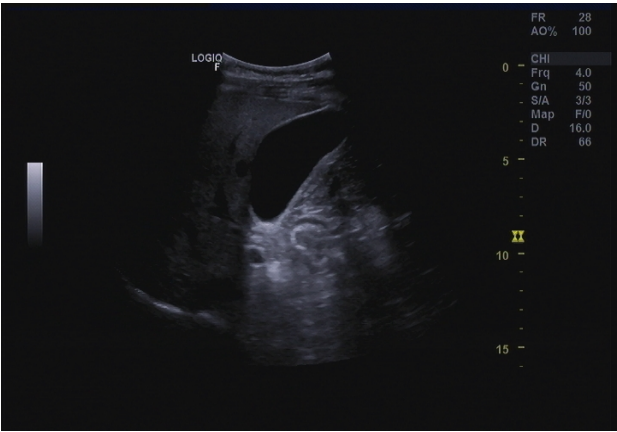
超声检查室

检查者： 杨少鹏

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态饱满，肝内实质回声细腻，略增强，分布不均匀，后	

	方回声衰减，肝内血管变细，显示欠清晰，CDFI:血流显示正常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
前列腺	未见明显异常	
颈动脉	颈动脉未见明显异常	

初步意见 中度脂肪肝



* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

放射科

检查者: 李如川 审核者: 吕计敏

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。	

	心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	
颈部	颈椎生理曲度正常，椎体骨质、椎间隙及附件骨结构正常。	
初步意见	未见明显异常	

经颅多普勒检查室

检查者： 孙明月

检查项目	检查所见	单位
经颅多普勒	探测脑底各动脉提示，血流速度在正常范围内，频谱形态正常，PI、RI、S/D正常，未闻血管杂音。	
初步意见	未见明显异常	

口腔科

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

耳鼻咽喉科

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

主检医师： 赵进南

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

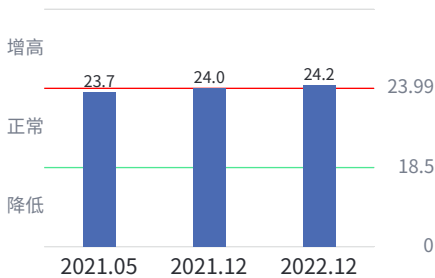
iKangCare+ 有人管的体检

4. 历年主要异常指标对比及健康指标预测

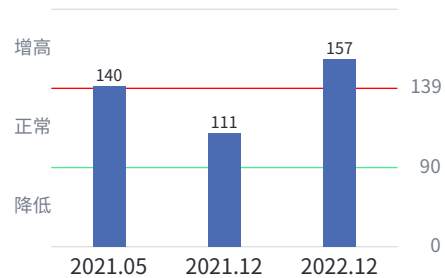
一般项目检查

检查项目	测量结果			单位	参考区间
	2021年05月	2021年12月	2022年12月		
体重指数	23.7	24.0	24.2		18.5-23.99
收缩压	140	111	157	mmHg	90.0-139.0
舒张压	86	72	91	mmHg	60.0-89.0

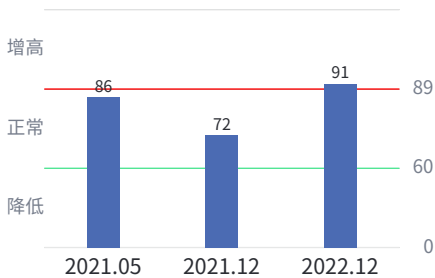
体重指数



收缩压 (mmHg)



舒张压 (mmHg)



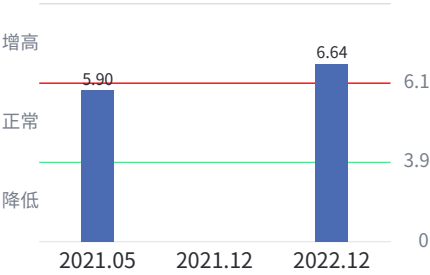
实验室检查

检查项目	测量结果			单位	参考区间
	2021年05月	2021年12月	2022年12月		
空腹血糖	5.90		6.64	mmol/L	3.90-6.10
总胆固醇	5.72		5.15	mmol/L	0-5.2
低密度脂蛋白胆固醇	3.16		2.92	mmol/L	0-4.14

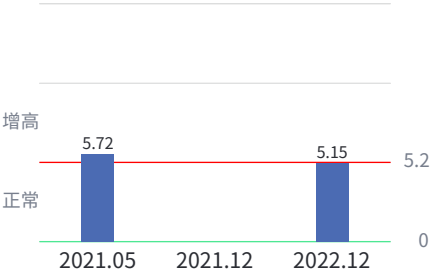


下载爱康APP
查看彩色报告

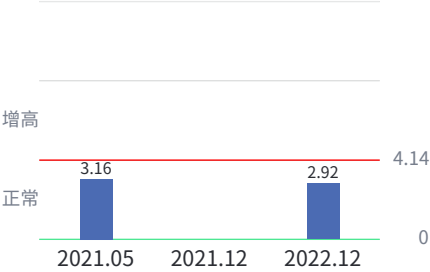
空腹血糖 (mmol/L)



总胆固醇 (mmol/L)



低密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)



5.医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

■ 什么是甘油三酯？



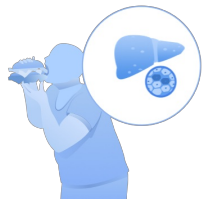
常有人将血脂与甘油三酯视为一体，实际上，甘油三酯（TG）仅是血脂的一种，血脂还包括其他物质如胆固醇等。当病人的血甘油三酯特别高（颗粒大、密度低的脂蛋白过多）时，血液会呈乳白色，将这种血静置一段时间后，血的表面会形成厚厚的一层奶油样物质，这便是化验单上报告的所谓的“甘油三酯”。甘油三酯的功能与胆固醇截然不同，甘油三酯是人体主要的能量储存库。尽管甘油三酯有诸多生理功能，但凡事物极必反，过多的甘油三酯会导致脂肪细胞功能改变和血液粘稠度增加，并增加患冠心病的危险性，而且，血液中甘油三酯过高还会引起急性胰腺炎。

■ 什么是体重指数？



目前常用的体重指数（body mass Index）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

■ 什么是脂肪肝？



指肝脏内脂肪含量增多，过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能，易受亲肝性毒物所损害，甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性，在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义，确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结构。

■ 什么是尿酸增高？



尿酸是体内和食物中嘌呤代谢的最终产物，又是细胞新陈代谢的副产品。肝是尿酸的主要生成场所，大部分尿酸通过肾排，血液中存在少量的尿酸。当肾脏不能清除尿液中足够的尿酸时，血液中尿酸增高，血中过多的尿酸可导致尿酸盐结晶沉积于关节内；同时食用高嘌呤饮食并饮酒可增加尿酸增高程度。尿酸增高不仅会引起痛风发作，还可导致肾脏病变。临床资料证实，尿酸还与高血压、糖尿病、冠心病等疾病密切相关。尿酸增高常见于肾小球滤过功能损伤、原发性痛风、血液病、恶性肿瘤等疾病，长期使用利尿剂和抗结核药也会导致尿酸增高。对于首次检出尿酸增高者，建议复查，明确病因，尽早治疗；对于有病史受检者，及时到肾内科就诊。

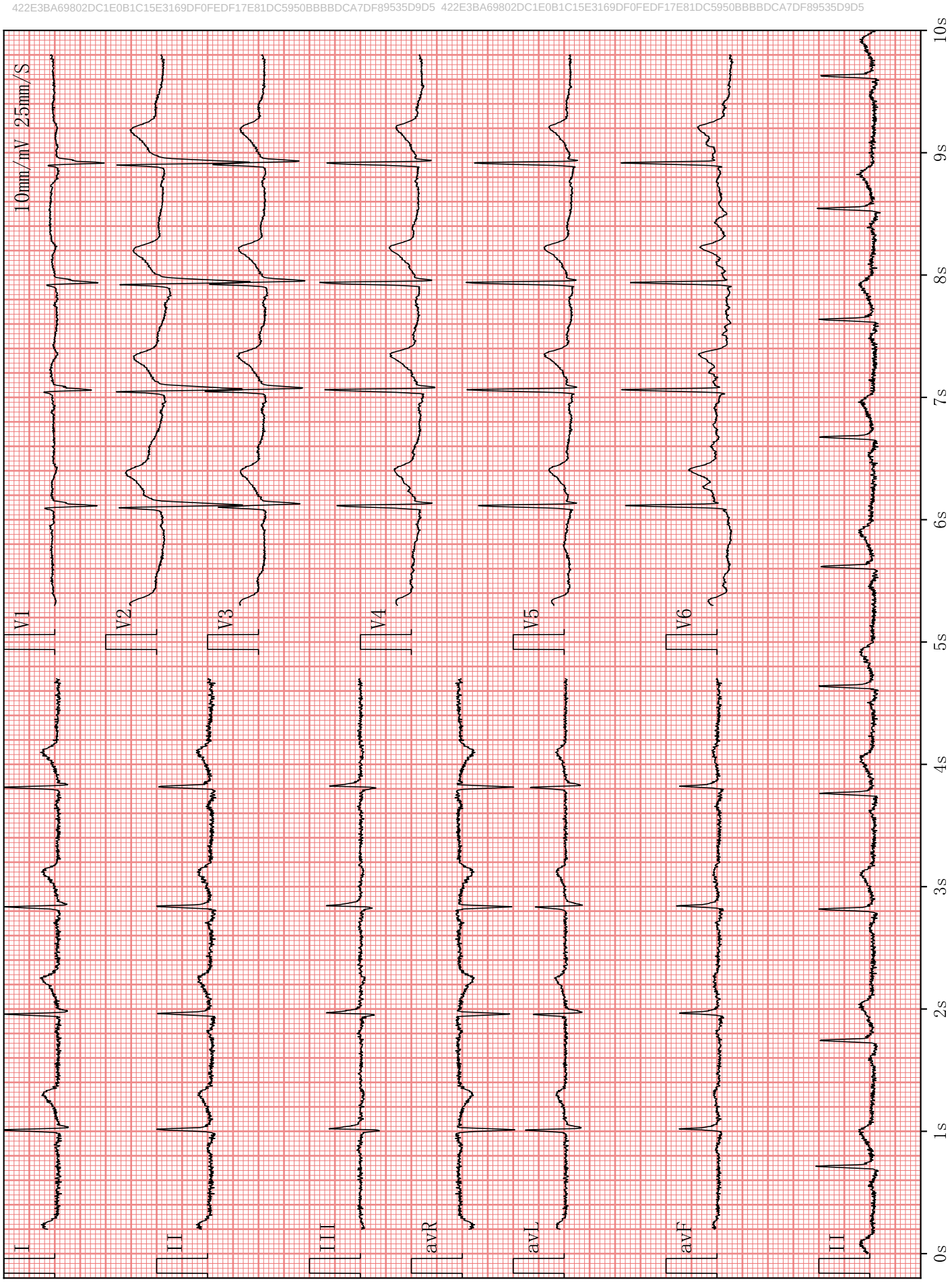


下载爱康APP
查看彩色报告

体检号:2222212130155

客户信息:杨少鹏/男/33

HR:60bpm PR:0.162s QTc:437 RV5/SV1:2.23mV/0.955mV
RR:1.0s QT:0.436s R+S:3.185 P/QRS/T轴:51°/32°/23°



422E3BA69802DC1E0B1C15E3169DF0FEDF17E81DC5950BBBBDCA7DF89535D9D5 422E3BA69802DC1E0B1C15E3169DF0FEDF17E81DC5950BBBBDCA7DF89535D9D5

检查者

杨少鹏